

אירוע טוקסולוגי המוני: אט"ה

אירוע טוקסיקולוגי המוני (אט"ה) יוגדר כאשר יש אירוע חומ"ס משולב עם אירוע רב־נפגעים. אירועי אט"ה בדרך כלל יהיו אירועים שבהם לנפגעים רבים יהיו אותם סימנים ללא קשר למנגנון הטראומה של האירוע. לנפגעים יהיו סימנים של גירוי עיניים וגירוי דרכי נשימה עליונות. בדרך כלל הנפגעים יגיעו מאותה גזרה גאוגרפית.

הכרזה על אט"ה

- 1) אט"ה יוכרז כאשר זהו אירוע רב־נפגעים - מספר הנפגעים וחומרת מצבם יוצרים אר"ן.
- 2) אט"ה יאופיין טריטוריאלי - הנפגעים מגיעים מגזרה ברורה, והמאפיין הוא שמי שנמצא באותה זירה נפגע; אין קשר לגיל הנפגעים.
- 3) בניתוח המחוללים האפשריים לאט"ה עולה שהחומרים העשויים לגרום לאט"ה הם מגרי ריריות, ולכן סביר שהסימנים הראשונים שרואים יהיו גירוי של הרירית בעיניים ושל הרירית בדרכי הנשימה העליונות שיתבטאו בתחושת צריבה, קוצר נשימה ושיעול.
- 4) נפגעים הנמלטים מזירה משתעלים, מתלוננים על צריבה קשה בעיניים ועל תחושת מחנק, מדווחים על נפגעים שהתמוטטו בתוך הזירה - הם הסימנים הקלאסיים לאט"ה.
- 5) גם באירוע שבו יש נפגעים דחופים וחומרת פגיעתם אינה מוסברת על ידי מנגנון הפגיעה (למשל קוצר נשימה חריף בהיעדר גל הדף, פרכוס בהיעדר פגיעת ראש) יש לחשוד בפיזור חומרים רעילים באירוע.

ההכרזה על אט"ה תיעשה על ידי איש הצוות הבכיר ביותר שנמצא בשטח. ההכרזה יכולה להתבצע כבר בעת קבלת הקריאה על ידי המוקד לפי המידע המתקבל - מספר הנפגעים, הסימנים הקליניים וסיפור האירוע. הכרזת האירוע תהיה על בסיס גילוי וזיהוי (גו"ז) קליני או נסיבות האירוע, למשל פגיעה במקלית, פגיעה ברכבת שנושאת חומ"ס, תקרית קשה במפעל כימי. ככל שההכרזה תהיה מוקדם יותר, צוותים יספיקו להתמקן ולא ייפגעו. מרגע ההכרזה עובדים על פי סד"פ (סדר פעולות) אט"ה המופיע בפנקס כיס לראש צוות מד"א, על פי השיטה של פתיחת מבר"ר (מרחק הבידוד הראשוני) סביב המבנה (כפי שהוסבר למעלה).

עקרונות פעולת הצוות הרפואי לאחר ההכרזה

- אם האירוע בשטח סגור - צוותי מד"א מגיעים לכל פתחי המבנה ומשם נכנסים למבנה כדי לדווח, לתת טיפול מציל חיים ולסייע בחילוץ
- אם האירוע בשטח פתוח - בהמשך עם קבלת נתוני מטאורולוגיה, יש לשנות את הפריסה כך שצוותים לא יהיו בכיוון הרוח
- המבר"ר באט"ה אינו שטח שאסור להיכנס אליו, אלא גבול הבא להזכיר לצוות להתמקן ולהיכנס ממוגנים
- נפגעים רבים נמלטים מהזירה ויש להיערך לקולטם באזור הנקי או בבית החולים
- עם הגעת הצוותים יש לכרוז לנפגעים, ולרכז את הנפגעים הקלים המהלכים
- מוודאים שמסירים שכבת בגדים עליונה ומכניסים אותם לשקיות כביסה מזהמת
- יש לזכור שבאט"ה ריכוז החומר הרעיל זמן החשיפה לחומר הרעיל הם המרכיבים המרכזיים בהישרדות

- האתגר המרכזי באט"ה הוא חילוץ מהיר של הנפגעים, ולכן גם הצוותים הרפואיים נדרשים לעבוד עם ציוד לחילוץ לצד הכוח המרכזי המחלץ
- המשימה העיקרית היא הצלת חיים על ידי הרחקת הנפגעים מהאזור המזוהם
- כמו באר"ן, גם באט"ה נדרש לאתר את המטופלים עם הסיכוי הגדול ביותר לשרוד
- יחד עם הצורך להרחיק את הנפגעים, סדר החילוץ שונה:
 - הראשונים יחולצו אלה המסוגלים ללכת - קוראים להם במערכות הכריזה או מובילים אותם בשרשרת; בשל הפרעות ראייה הנפגעים אינם יכולים לראות לאן ללכת
 - לאחר מכן מוציאים את השוכבים המראים סימני חיים (הנפגע זז/ משתעל/ מפרכס)
 - אלו שאינם מראים סימני חיים יחולצו בשלב השני, בעדיפות על ידי אנשי צוות הממוגנים בערכות מיגון דרגה A
- איש צוות ממוגן אינו יכול לקבוע שאדם אינו נושם או אין לו דופק. לכן מוציאים את כולם, למעט כאלה שאיבדו צלם אנוש; אלו יושארו בזירה
- בשל אופי המיגון של הצוותים הרפואיים המטופלים הכניסה תהיה עד לקו שבו נצפים נפגעים חיים
- קביעת המוות תיעשה מחוץ לאזור המזוהם
- חילוץ הנפגעים הוא פעילות הדורשת מאמצים רבים, ולכן יש חשיבות רבה לאספקת אמצעי נשיאה כולל מיטות אמבולנס שעליהן קל יותר לנייד את הנפגעים
- באט"ה העדיפות היא לשימוש ברכבי הצלה. צוות מגיע לגבול מב"ר, מתמגן, מעלה כמה שיותר נפגעים ומפנה
- כאשר הפינוי יהיה בשטח עירוני אמבולנסים מפנים ישירות לבית החולים
- זיהום האמבולנס אינו גורם לסכנה סביבתית, אך בתוך חלל האמבולנס, בשל היעדר אוורור, הצוות חייב להמשיך לעבוד ממוגן כדי שלא להיחשף לחומ"ס. לכן גם נוסעים עם חלונות פתוחים ללא הפעלת מזגן ומפשיטים תוך כדי נסיעה כדי לצמצם את החשיפה של הנפגעים
- הדלקה או כיבוי של המזגן תלויה בסוג הפגיעה ובשטח הכווייה אם ישנה. פתיחת החלונות בהקשר לזיהום בחומ"ס היא להקטין את כמות החומר הרעיל באמבולנס
- במתאר מרוחק מתחנות מד"א שבו צבירת הכוח מתארכת, כלומר נדרש זמן לאיסוף כוח רפואי וצוותי אלונקאים ומטהרים, יש להפעיל אמבולנסים בתוך המב"ר לצורך פינוי נפגעים עד לגבול המב"ר
- מפשיטים את הנפגעים השוכבים כדי למנוע המשך חשיפה, וחוזרים פנימה לאזור הטיפול
- בהתחלת האירוע כל איש צוות ממוגן מטפל בהפשטה, ובהמשך עושים זאת אנשי הצוות שאחראים על ההפשטה. מטרתם של אנשי צוות אלו היא לשחרר את הצוות הרפואי כדי שיוכלו לטפל בנפגעים.
- אומנם זה פתרון מסורבל אך אין לו תחליף בהיעדר כוחות מספיקים בזירה
- יש להדגיש את חשיבות הפשטת הנפגעים טרם עלייתם לרכבי ההצלה על מנת להסיר את מרב הזיהום ובמקרה זה יש להקפיד לנסוע בחלונות פתוחים, ללא מזגן, והצוות אינו נדרש למיגון למעט מיגון סטנדרטי הכולל כפפות, מסכה וחלוק

